

+ 外来患者指導シリーズ第38弾

本当に危ないのは、 1回の飲み忘れ ではありません

心房細動の外来で、先に決めておく「次の日」の約束

飲み忘れの約束

脈の測り方

お酒とコーヒー



医知創造ラボ

監修：今村久司（脳神経内科・総合内科専門医）

「控えましょう」を、 並べるのをやめる

結論

- ① 飲み忘れで危ないのは「1回分」ではなく、そこから中断に転がること
- ② 脈は「触らせる」より「測らせる」。家庭血圧計のほうが指より正確
- ③ 減らすのはお酒。やめさせないのはコーヒー

よく聞かれる 5つの疑問

- 1** | 薬を1回飲み忘れたら、どうすればいい？
- 2** | 発作が起きているか、自分で分かる？
- 3** | お酒はやめないとだめですか？
- 4** | コーヒーもやめたほうがいい？
- 5** | 歯を抜くとき、薬は止めるの？

① まず、この薬がどれだけ効くのか **HOW WELL IT WORKS**

3分の1に

**抗凝固薬をのむと、
脳梗塞の起こる確率はここまで下がる**

ガイドラインが患者さん向けに使っている表現。29試験・28,044人のメタ解析では64%減
2024年 JCS/JHRS フォーカスアップデート版 不整脈治療 / Hart RG, et al. Ann Intern Med.
2007;146(12):857-67.

① ところが、現実はこうです **ADHERENCE IN PRACTICE**

8割きちんと飲めている人は、 半分もいない

飲んでいる薬	8割以上のむ日をカバーできた人
DOAC（直接経口抗凝固薬）	47.5%
ワルファリン	40.2%

📋 だから「飲み忘れないで」だけでは動かない

忘れることを前提に、忘れたあとの決めごとをつくる

心房細動 64,661人・追跡中央値1.1年。Yao X, et al. J Am Heart Assoc. 2016;5(2):e003074.

① ここを取り違えない NOT ONE DOSE

危ないのは1回分ではなく、 飲まない期間が伸びること



1回飲み忘れると、脳梗塞が起きる



測られていたのは1週間～半年の「飲まない期間」

飲んでいなかった期間	脳梗塞の起こりやすさ（1週間未満と比べて）
1～3か月	1.96倍
3～6か月	2.64倍
6か月以上	3.66倍

脳梗塞リスクが高い人（CHA2DS2-VAScスコア4以上）での値。同上

① 外来で先に決めておく **THREE PROMISES**

紙に書いて渡すのは、 この3つだけ

1



まとめない
共通ルール

2回分をまとめて飲まない

:

2



先に決める
薬ごとに違う

気づいたときどうするかを、主治医と決めて書いておく

:

3



戻す
いちばん大事

忘れた日があっても、翌日からいつもどおりに戻す

検脈は、いちばん強い推奨で すすめられている

65歳以上の定期的な検脈

推奨クラスⅠ
エビデンスレベル A

3月9日は「脈の日」、
3月9～15日は「心房細動週間」

ただし、この推奨は

「見つける」
ためのもの

診断ずみの人の再発モニタリングに、
同じ強さの推奨があるわけではない

2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン 表22 / Ono K, et al. Circ J. 2022;86(11):1790-1924.

脈は、 何で測ると当たるのか

測り方	見落としにくさ（感度）	空振りの少なさ（特異度）
家庭用の血圧計	0.98	0.92
12誘導でない心電計	0.91	0.95
指で脈を触る	0.92	0.82

指で触る方法は「見落としは少ないが、空振りが多い」。だから乱れを感じただけで救急ではない。
21研究・15,129回の脈評価。Taggar JS, et al. Eur J Prev Cardiol. 2016;23(12):1330-8.

20回から

**家庭血圧は、20回以上ためて
はじめてリスクが見えてくる**

75歳以上の心房細動 4,933人。上が145以上で脳卒中・大出血・頭蓋内出血が増えた。この
関連は測定20回以上でのみ観察された
ANAFIEレジストリ。Kario K, et al. Hypertension. 2022;79(12):2696-2705.

③ 通知を持ってこられたら SMARTWATCH ALERTS

11

通知が出た人のうち、 心房細動だったのは3人に1人



通知が出た＝心房細動だ



心電図で確認できたのは34%。
画面を持って、次の受診で見せる

41万9,297人が参加。通知を受けたのは0.52%で、2回目の通知と同時記録での的中率は0.84。
対象は「心房細動がない」と自己申告した人。Perez MV, et al. N Engl J Med. 2019;381(20):1909-1917.

④ お酒は「やめる」ではない **CUT DOWN, NOT QUIT**

減らした分だけ、 発作は減っていた

週**16.8杯** → 週**2.1杯**

再発 **53%**

ゼロにした人たちではない。減らせた人たちの結果

これまでどおり飲んだ人

再発 **73%**

再発までの期間の差はハザード比 0.55

週10杯以上飲む心房細動 140人の無作為化試験・6か月。ガイドラインの推奨はクラスIIa。

Voskoboinik A, et al. N Engl J Med. 2020;382(1):20-28.

4時間

**1杯飲んだあとの4時間は、
発作の起こりやすさが約2倍**

2杯以上では約3.6倍。心電図とアルコールセンサーを4週間つけた100人の解析。
飲んだ日に何が起きるかを、本人に観察してもらう。Marcus GM, et al. Ann Intern Med.
2021;174(11):1503-1509.

⑤ ここが、いちばん変わった DO NOT STOP THE COFFEE

コーヒーをやめた群のほうが、 再発が多かった

毎日1杯以上のみ続けた

再発 47%

ハザード比 0.61 (39%低い)

完全にやめた

再発 64%

有害事象に差はなかった

もともとコーヒーを飲んでいて200人の無作為化試験。飲まない人に勧める根拠ではない。

2024年のガイドラインも「近年は適切なカフェイン摂取習慣は心房細動のリスクを高めず」と記載。

Wong CX, et al. JAMA. 2026;335(4):317-325. (DECAF試験)

⑥ 発作そのものを減らす **WEIGHT, EXERCISE, SLEEP**

効くと分かっているのは、 体重・運動・いびき

- ✓ 体重を10%以上減らす と、不整脈のない生存が6倍（観察研究）
- ✓ 運動を6か月 で、発作がない人が20%から40%へ
- ✓ いびきをかく人は、睡眠時無呼吸の検査へ

 「運動しましょう」の前に確かめる

心拍数がコントロールできていない頻脈性心房細動では、運動療法は相対的禁忌

Pathak RK, et al. JACC. 2015;65(20):2159-69. / Elliott AD, et al. JACC Clin EP. 2023;9(4):455-465.

抜歯・胃カメラで、 自分の判断で止めない



① 抜歯・白内障・通常の内視鏡は原則そのまま

ガイドラインが
「出血低リスク手技」に分類している



② 止めるほうが危ない

抜歯でワルファリンを休薬すると
約1%に重篤な脳梗塞という報告

確認するのは、処置をする医師。患者さんは「予定が入りました」と伝えるだけでいい

今日の3つの持ち帰り

01

飲み忘れて危ないのは「1回分」ではなく、そこから中断に転がること

02

脈は「触らせる」より「測らせる」。
家庭血圧計のほうが指より正確

03

減らすのはお酒。
やめさせないのはコーヒー

この動画の根拠

- | | |
|---|---|
| 1 Iwasaki YK, et al. Circ J. 2025;89(7):1012-1073. | 2 Ono K, et al. Circ J. 2022;86(11):1790-1924. |
| 3 Hart RG, et al. Ann Intern Med. 2007;146(12):857-67. | 4 Yao X, et al. J Am Heart Assoc. 2016;5(2):e003074. |
| 5 Taggar JS, et al. Eur J Prev Cardiol. 2016;23(12):1330-8. | 6 Kario K, et al. Hypertension. 2022;79(12):2696-2705. |
| 7 Perez MV, et al. N Engl J Med. 2019;381(20):1909-1917. | 8 Voskoboinik A, et al. N Engl J Med. 2020;382(1):20-28. |
| 9 Marcus GM, et al. Ann Intern Med. 2021;174(11):1503-1509. | 10 Wong CX, et al. JAMA. 2026;335(4):317-325. |
| 11 Pathak RK, et al. J Am Coll Cardiol. 2015;65(20):2159-69. | 12 Elliott AD, et al. JACC Clin Electrophysiol. 2023;9(4):455-465. |

ほかの引用はブログ記事の参考文献をご覧ください。すべてPubMedで実在を確認しています。